**ЗАТВЕРДЖЕНО**
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
14 лютого 2012 року № 110

| | |
|---|---|
| **АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ**<br>**ДУ "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова"**<br>м.Київ, вул. Академіка Шалімова 30<br>Код за ЄДРПОУ 4 5 2 3 3 9 6 7 | **МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**<br>Форма первинної облікової документації<br>**№ 027/о**<br>**ЗАТВЕРДЖЕНО**<br>Наказ МОЗ України<br>**14 02 2 0 1 2** № **1 1 0** |

**Відділення гепатобіліарної, вісцеральної і ендокринної хірургії та органної трансплантації**

**ВИПИСКА**
**із медичної карти стаціонарного хворого № 10098/2026**

У Поліклініку за місцем проживання
(найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого **Жерліцина Анастасія Станіславівна**

2. Дата народження 25.04.1976
(число, місяць, рік)

3. Місце проживання хворого: Житомирська обл., м. Малин, вул. Героїв Крут 30Б.

4. Місце роботи (посада): не працює.

5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі:
захворювання _____ (число, місяць, рік)
направлення в стаціонар _____ (число, місяць, рік)
б) у стаціонарі: надходження _____ **19.10.2026** (число, місяць, рік)
**виписки** або смерті (підкреслити) _____ **05.11.2026** (число, місяць, рік)

6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення):

**Основний**: GIST шлунку cT2N0M1 (hep), (ypT2N0M1(hep)), IV стадія. Стан після терапії іматинібом та хірургічного лікування.
**Ускладнення**:
**Супутній**: Лейоміома матки. Ендометріома правого яйника. Залізодефіцитна анемія.

7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці

Скарги: загальна слабкість. Анамнез захворювання: хворіє з 08.2022, коли було виявлено множинне білобарне ураження печінки, парагастральне утворення та утворення малого таза. Первинно процес трактувався як метастатична лейоміосаркома матки, у зв'язку з чим отримувала системну терапію гемцитабіном, доцетакселом, бевацизумабом, надалі пазопанібом та трабектедином, без стійкого ефекту. Після повторних біопсій і перегляду гістологічного матеріалу у 2023 році діагноз переглянуто на GIST шлунка з метастатичним ураженням печінки. З 03.05.2023 отримувала іматиніб 400 мг/добу з вираженою метаболічною відповіддю та стабілізацією захворювання до 2025 року. З 06.2026 за даними ПЕТ-КТ відзначено прогресування метастатичного ураження печінки. Молекулярне дослідження від 08.2026 виявило первинну мутацію KIT exon 11 та вторинні мутації KIT exon 13 і exon 18, що відповідають резистентності до іматинібу. За даними ПЕТ-КТ від 23.09.2026 — подальше метаболічне прогресування множинних вогнищ печінки. Розглядались локорегіонарні та хірургічні методи лікування; термоабляція вогнища лівої частки визнана технічно недоцільною. 30.09.2026 призначено регорафеніб 160 мг/добу, лікування на момент госпіталізації не розпочато. Пройшла МОК в умовах ННЦХТ. Госпіталізована в плановому порядку в IV відділення ННЦХТ для оперативного лікування. Копії усіх обстежень прикріплені до історії хвороби. З основних обстежень: 02.10.2026 ЕКГ Ритм синусовий регулярний з ЧСС 70/хв. Вертикальна ЕВС. ЕКГ графіка - без патологічних змін. 23.09.2026 ПЕТ-КТ від надрівних дуг до с/3 стегна ПЕТ/КТ-ознаки приросту метаболічної активності в множинних вогнищах ураження паренхіми печінки в порівнянні з ПЕТ/КТ від 19.06.2026р., що характерно для прогресії основного захворювання. Стабільне низькоінтенсивне утворення тіла матки та стабільний метаболічний вузол тіла матки без вираженої динаміки. Зберігається стабільне FDG-негативне утворення тіла шлунку. Фіксація РФП в стравоході може відповідати запальному генезу, проте, рекомендовано дообстеження - ЕГДС. нших даних за FDG- позитивний патологічний процес не виявлено. 02.10.2026 ФЕГДС Еритематозна гастропатія. Дуоденогастральний рефлюкс жовчі. 02.10.2026 ВКС Стан після апендектомії (1982р.). Поодинокі (3) неоплазії товстої кишки. Ендоскопічні ознаки доліхосигми. Хронічний внутрішній геморой. 06.10.2026 ПГД №422/26 ННЦХТ Фрагмент утворення шлунку представлений гіалінізованою тканиною, без вітальних клітин пухлини, що може бути наслідком проведеної терапії. У матеріалі трепан-біопсії печінки - метастаз гастроінтестинальної стромальної пухлини (GIST), веретеноклітинний варіант, Low Grade. 14.10.2026 Цитологія №996/26 CSD За міжнародною класифікацією (IRSSFC) – категорія AUS (Atypia of undetermined significance) якість зразка та техніка приготування препаратів, відсутність цитоблоку, не дають можливість цитологічно визначити походження клітин в щільних групах (враховуючи клінічний діагноз). Страховий анамнез: лікарняний лист – не потребує, на момент госпіталізації на лікарняному листку не перебуває. Анамнез життя: зі слів пацієнтки, туберкульозом, венеричними та іншими інфекційними захворюваннями не хворіла. Соматичні захворюваня: заперечує. Прийом препаратів на постійній основі: див. в IX. Алергологічний анамнез: заперечує. Онкологічний анамнез: див. діагноз. Перенесені операції: 1982 – Апендектомія. 05.10.2026 - Діагностична лапароскопія. Інцизійна біопсія новоутворення шлунка. Трепан-біопсія вогнищевого утворення Sg II-III печінки під УЗ-контролем. Інфекційний анамнез: не обтяжений.

**Група крові: O(I) Rh –**

**Аналізи:**

| Дата | Назва аналізу | Результат |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | A34011 - Клінічний аналіз крові | Лейкоцити (WBC) 5,34 Г/л (4,0 - 8,4); Нейтрофіли (NEU, відносна кількість) 51,9 % (40,0 - 75,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 37,6 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 5,3 % (1,0 - 9,0); Еозинофіли (EOS, відносна кількість) 4,4 % (0,5 - 5,0); Базофіли (BAS, відносна кількість) 0,8 % (0 - 1); Нейтрофіли (NEU#, абсолютна кількість) 2,78 Г/л (1,80 - 6,30); |

| | | |
|---|---|---|
| | | Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 2,01 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,28 Г/л (0,1 - 0,7); Еозинофіли (EOS#, абсолютна кількість) 0,23 Г/л (0,03 - 0,4); Базофіли (BAS#, абсолютна кількість) 0,04 Г/л (0 - 0,1); Еритроцити (RBC) 3,14 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 112 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 31,6 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 100,6 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 35,7 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 354,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 12,7 % (12,0 - 15,0); Тромбоцити (PLT) 265,0 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 9,0 фл (7,0 - 10,0); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 16,0 фл (9,0 - 17,0); Тромбокрит (PCT) 0,238 % (0,108 - 0,282); Швидкість осідання еритроцитів (ESR) 28 мм/год (2 - 15); |
| 20.10.2026 | A34030 - Аналіз; біохімія | Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 24 Од/л (< 41); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 29 Од/л (< 40); Білірубін загальний (BT, DPD) 11,0 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Білірубін прямий (BD, DPD) 2,1 мкмоль/л (< 3,4); Глюкоза 5,0 ммоль/л (3,9 - 6,1); Білок загальний 71,1 г/л (65,0 - 85,0); Креатинін 99,0 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 3,9 ммоль/л (< 8,3); Амілаза 91 Од/л (20 - 104); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH, IFCC) 247 Од/л (< 247); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 69 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 20 Од/л ( < 30); Альбумін 39,6 г/л (35,0 - 50,0); Електроліти: Калій 4,35 ммоль/л (3,50 - 5,30); Натрій 140,1 ммоль/л (135,0 - 145,0); Хлор 104,1 ммоль/л (98,0 - 107,0); |
| 20.10.2026 | B34025 - Аналіз; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) | Фібриноген [Маса/об'єм] у Плазмі, бідній тромбоцитами Методом коагуляції: 350 (мг/дл); Протромбіновий індекс (ПТІ): 97 (відсоток); Міжнародне нормалізоване відношення у Крові Методом коагуляції: 1.02 ({мнв}); Протромбіновий час: 13.5 (секунда) |
| 21.10.2026 | A34011 - Клінічний аналіз крові | Лейкоцити (WBC) 8,09 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,74 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,29 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 6,1 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 21,5 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 3,6 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 74,9 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,53 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 86 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 25,5 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 100,8 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 34,1 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 338,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 11,8 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 47,6 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 160,7 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 7,4 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,120 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 17,0 фл (9,0 - 17,0); |
| 21.10.2026 | B34029 - Аналіз; коагулограма | Протромбіновий час (ПЧ, PT, сек) 20,1 сек (10 - 17); Відсоток протромбіну за Квіком 54 % (80 - 110); Міжнародне нормалізоване відношення (INR) 1,58 (0,90 - 1,20); Фібриноген (за Клаусом) 2,3 г/л (2,0 - 4,0); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 35,4 сек (30,0 - 45,0); |
| 22.10.2026 | A34011 - Клінічний аналіз крові | Лейкоцити (WBC) 7,86 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 0,87 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,13 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 6,9 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 11,1 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 1,6 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 87,3 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,46 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 83 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 24,8 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 100,8 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,9 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 336,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 11,9 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 48,0 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 141,6 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 7,7 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,110 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 17,9 фл (9,0 - 17,0); |
| 22.10.2026 | A34030 - | Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 558 Од/л (< 41); |

| | | |
|---|---|---|
| | Аналіз; біохімія | Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 530 Од/л (< 40); Білірубін загальний (BT, DPD) 17,8 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Креатинін 71,9 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 4,5 ммоль/л (< 8,3); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH, IFCC) 555 Од/л (< 247); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 57 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 16 Од/л ( < 30); Альбумін 34,1 г/л (35,0 - 50,0); |
| 22.10.2026 | B34029 - Аналіз; коагулограма | Протромбіновий час (ПЧ, PT, сек) 20,4 сек (10 - 17); Відсоток протромбіну за Квіком 53 % (80 - 110); Міжнародне нормалізоване відношення (INR) 1,60 (0,90 - 1,20); Фібриноген (за Клаусом) 2,3 г/л (2,0 - 4,0); |
| 23.10.2026 | A34011 - Клінічний аналіз крові | Лейкоцити (WBC) 6,59 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,06 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,14 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 5,4 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 16,1 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 2,1 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 81,8 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,26 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 78 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 22,8 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 100,9 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 34,3 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 340,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 11,8 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 47,6 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 127,0 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 7,6 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,100 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 16,8 фл (9,0 - 17,0); |
| 23.10.2026 | A34030 - Аналіз; біохімія | Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 322 Од/л (< 41); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 261 Од/л (< 40); Білірубін загальний (BT, DPD) 19,7 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Білірубін прямий (BD, DPD) 5,2 мкмоль/л (< 3,4); Глюкоза 4,8 ммоль/л (3,9 - 6,1); Білок загальний 55,3 г/л (65,0 - 85,0); Креатинін 67,1 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 4,0 ммоль/л (< 8,3); Амілаза 147 Од/л (20 - 104); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH, IFCC) 321 Од/л (< 247); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 62 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 15 Од/л ( < 30); Альбумін 34,7 г/л (35,0 - 50,0); Електроліти: Калій 3,70 ммоль/л (3,50 - 5,30); Натрій 134,8 ммоль/л (135,0 - 145,0); Хлор 101,0 ммоль/л (98,0 - 107,0); |
| 23.10.2026 | A34011 - Клінічний аналіз крові | Лейкоцити (WBC) 6,37 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,12 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,19 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 5,1 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 17,7 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 2,9 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 79,4 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,68 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 91 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 26,3 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 98,1 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,8 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 344,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 13,2 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 51,8 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 108,6 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 7,5 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,080 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 17,3 фл (9,0 - 17,0); |
| 24.10.2026 | A34011 - Клінічний аналіз крові | Лейкоцити (WBC) 6,19 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 0,95 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,12 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 5,1 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 15,3 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 2,0 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 82,7 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,78 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 93 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 27,0 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 97,1 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,6 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 346,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 13,2 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 51,3 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 117,5 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 8,1 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,100 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 16,9 фл (9,0 - 17,0); |

| | | |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | A34011 - Клінічний аналіз крові | Лейкоцити (WBC) 5,23 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,04 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,30 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 3,9 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 19,9 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 5,8 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 74,4 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,73 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 92 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 26,6 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 97,4 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,7 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 345,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 13,2 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 51,4 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 122,1 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 8,1 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,100 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 18,3 фл (9,0 - 17,0); |
| 26.10.2026 | A34011 - Клінічний аналіз крові | Лейкоцити (WBC) 5,27 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,20 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,17 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 3,9 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 22,8 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 3,2 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 74,0 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,65 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 89 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 25,7 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 97,0 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,4 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 345,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 13,2 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 51,2 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 144,5 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 8,1 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,120 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 18,0 фл (9,0 - 17,0); |
| 26.10.2026 | A34030 - Аналіз; біохімія | Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 77 Од/л (< 41); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 61 Од/л (< 40); Білірубін загальний (BT, DPD) 9,4 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Білірубін прямий (BD, DPD) 2,5 мкмоль/л (< 3,4); Глюкоза 5,4 ммоль/л (3,9 - 6,1); Білок загальний 53,7 г/л (65,0 - 85,0); Креатинін 62,0 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 3,6 ммоль/л (< 8,3); Амілаза 134 Од/л (20 - 104); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) 215 Од/л (200 - 450); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 52 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 28 Од/л ( < 30); Альбумін 33,6 г/л (35,0 - 50,0); Електроліти: Калій 3,88 ммоль/л (3,50 - 5,30); Натрій 135,0 ммоль/л (135,0 - 145,0); Хлор 97,9 ммоль/л (98,0 - 107,0); |
| 26.10.2026 | B34029 - Аналіз; коагулограма | Протромбіновий час (ПЧ, PT, сек) 14,5 сек (10 - 17); Відсоток протромбіну за Квіком 87 % (80 - 110); Міжнародне нормалізоване відношення (INR) 1,10 (0,90 - 1,20); Фібриноген (за Клаусом) 2,7 г/л (2,0 - 4,0); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 36,5 сек (30,0 - 45,0); |
| 26.10.2026 | A33007 - Аналіз; посів на флору і чутливість до антибіотиків | Біоматеріал Вміст черевної порожнини; Виділений мікроорганізм Ріст не виявлено; |
| 30.10.2026 | A34011 - Клінічний аналіз крові | Лейкоцити (WBC) 6,68 Г/л (4,0 - 8,4); Нейтрофіли (NEU, відносна кількість) 66,2 % (40,0 - 75,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 19,8 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 9,0 % (1,0 - 9,0); Еозинофіли (EOS, відносна кількість) 4,7 % (0,5 - 5,0); Базофіли (BAS, відносна кількість) 0,3 % (0 - 1); Нейтрофіли (NEU#, абсолютна кількість) 4,43 Г/л (1,80 - 6,30); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,32 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,60 Г/л (0,1 - 0,7); Еозинофіли (EOS#, абсолютна кількість) 0,31 Г/л (0,03 - 0,4); Базофіли (BAS#, абсолютна кількість) 0,02 Г/л (0 - 0,1); Еритроцити (RBC) 2,64 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 94 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 26,2 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 99,2 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 35,6 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 359,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 14,4 % (12,0 - 15,0); Тромбоцити (PLT) 273,0 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм |

| | | |
|---|---|---|
| | | тромбоцитів (MPV) 9,6 фл (7,0 - 10,0); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 16,3 фл (9,0 - 17,0); Тромбокрит (PCT) 0,262 % (0,108 - 0,282); |
| 30.10.2026 | A34030 - Аналіз; біохімія | Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 42 Од/л (< 41); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 38 Од/л (< 40); Білірубін загальний (BT, DPD) 6,1 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Білірубін прямий (BD, DPD) 1,6 мкмоль/л (< 3,4); Глюкоза 6,9 ммоль/л (3,9 - 6,1); Білок загальний 56,7 г/л (65,0 - 85,0); Креатинін 91,5 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 9,2 ммоль/л (< 8,3); Амілаза 144 Од/л (20 - 104); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH, IFCC) 212 Од/л (< 247); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 58 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 27 Од/л ( < 30); Альбумін 37,7 г/л (35,0 - 50,0); Електроліти: Калій 4,84 ммоль/л (3,50 - 5,30); Натрій 127,7 ммоль/л (135,0 - 145,0); Хлор 91,9 ммоль/л (98,0 - 107,0); |
| 30.10.2026 | B34025 - Аналіз; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) | Протромбіновий індекс (ПТІ): 89 (відсоток); Протромбіновий час: 14.3 (секунда); Міжнародне нормалізоване відношення у Крові Методом коагуляції: 1.08 ({мнв}); Фібриноген [Маса/об'єм] у Плазмі, бідній тромбоцитами Методом коагуляції: 350 (мг/дл) |
| 02.11.2026 | A34030 - Аналіз; біохімія | Білок загальний 55,0 г/л (65,0 - 85,0); |
| **03.11.2026** | **D37001 - Аналіз; гістопатологія; травлення** | **<u>ПГЗ №4488/26:</u>**<br>**1. Гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST) шлунку, веретеноклітинний варіант з явищами лікувального патоморфозу IIIст. (визначаються поодинокі групи CD117-позитивних клітини на фоні гіалінізованої тканини, що займають до 1% об'єму). У лімфатичних вузлах прилеглого фрагменту малого чепця – реактивна гіперплазія (2 шт.). У тканині печінки метастази гастроінтестинальної стромальної пухлини шлунку, High Grade (мітотичний індекс >5/50 полів зору х400), у вигляді двох поруч розташованих утворень: одне з них з вираженою кістозною трансформацію, друге у вигляді солідного вузла. В обох метастатичних вогнищах на фоні поширених ділянок гіпоклітинного гіалінозу (прояв лікувального патоморфозу) наявні осередки збереженого пухлинного росту. Лікувальний патоморфоз пухлин печінки II-IIIст. Краї резекції по тканині печінки та шлунку без ознак пухлинного росту (R0). Хронічний атрофічний холецистит, у лімфатичному шийки жовчного міхура (1шт.) – явища синусового гістіоцитозу. урT2 урN0(0/2) урM1(hep), High Grade, R0. ICD-O-4 code 89360/3.**<br>**2. У жировій клітковині малого чепця поруч зі стінкою шлунку, в окремо надісланому фрагменті жирової клітковини та у фрагменті тканини, що була надана на експрес-гістологію – осередки росту десмоїдного фіброматозу. ICD-O-4 code 88210/1.** |

**Обстеження:**

| Дата | Назва аналізу | Результат |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 11700-00 - [ЕКГ] | Синусовий ритм з чсс 72 уд. ВЕВС. Графіка без патологічних змін. |
| 20.10.2026 | 55113-00 - Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі | Атеросклероз аорти. Дегенеративні зміни мітрального клапану.Порожнини серця не розширені.Нормокінезія.Систолічна функція міокарда хороша.ФВ 70% |
| 26.10.2026 | 55036-00 - Ультразвукове дослідження черевної порожнини | Ліва доля печінки - неоднорідна, в/п ж/п не розширені. В 3 сегменті, на межі з 2 сементом, з лівою портальною веною - неоднорідне гіпоехогенне утворення 4.5 х 4.0 см. По краю резекції, без додаткових утворень. В ч/п, порожнині м/т - рідинних скупчень не виявлено. |
| 30.10.2026 | 55036-00 – УЗД ОЧП | В черевній порожнині, порожнині малого тазу - вільної рідини немає. |

| | | |
|---|---|---|
| **05.11.2026** | **Консультація лікаря-онколога (Петельський П.В.)** | Д-з: GIST шлунку cT2N0M1 (hep), (ypT2N0M1(hep)), IV стадія. Стан після терапії іматинібом та хірургічного лікування.<br>Рек-но:<br>1. Регорафеніб 40 мг 4 таб. 1 р/добу протягом 21 дня.<br>2.Контроль КТ ОГП, ОЧП, ОМТ із в/в к.п. через 1 місяць. |

**Оперативне втручання:**

| Дата | Час | Код процедури/ хірургічної операції | Назва процедури/ хірургічної операції | Спеціаліст |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 09:10 | 92514-29 | Загальна анестезія | Лисенко А. Ю. |
| **21.10.2026** | **13:10** | **30443-00<br>30418-00<br>30520-00** | **Правобічна гемігепатектомія. Холецистектомія. Клиновидна резекція шлунку** | **Федоров Д.О.** |

Післяопераційний період протікав без ускладнень. Станом на 05.11.2026 дані за гостру хірургічну патологію відсутні.

Пацієнтка в задовільному стані виписується під нагляд та лікування хірурга, онколога та сімейного лікаря за місцем проживання. Усі рекомендації надано.

**8. Лікувальні і трудові рекомендації:**

1. Спостереження та подальше лікування у хірурга та сімейного лікаря за місцем проживання.
2. Догляд за п/о раною: перев’язки 1р/день розчином «Бетадин».
3. Суворе обмеження фізичного навантаження та обов’язкове носіння післяопераційного бандажу протягом 3 місяців.
4. Омепразол (Нольпаза/Проксіум/Нексіум/Контролок) по 40 мг/2 на добу – 07:00, 19:00 – за умови прийому НПЗП.
5. Німесил 1 пакетик - при потребі.
6. Контроль КТ ОГП, ОЧП, ОМТ із в/в к.п. через 1 місяць.
7. Подальше лікування та спостереження у лікаря-онколога за місцем проживання. Консультація видана на руки.
8. Рекомендовано експертний перегляд гістологічних препаратів (скелець) з метою отримання незалежного патоморфологічного висновку (second opinion) з приводу «осередків росту десмоїдного фіброматозу». ПГЗ видано на руки.
9. Консультація в ННЦХТ за результатами КТ з вирішенням питанням про другий етап хірургічного лікування новоутворень лівої частки печінки.

**Лікуючий лікар** **Олександр Остапишен**

**Завідуючий відділенням** **Олег Симонов**

**05.11.2026 року**